

Cambiar la vía, explorar el circuito

Guía para participantes. Compara una visita conjunta cada 3 semanas: **Tecentriq 1.200 mg IV o 1.875 mg SC + bevacizumab 15 mg/kg IV**. Contexto: adultos con CHC avanzado o irresecable sin terapia sistémica previa. Dosis sin prescripción; otras pautas IV fuera del modelo. [1,2]

Prueba en tres pasos. 1. Ajusta el volumen y la proporción SC. 2. Explora sillones y tiempos locales. 3. Compara sillón, estancia y enfermería. Ejemplo totalmente sintético de un hospital ficticio; sin datos asistenciales observados.

Datos publicados, sintéticos y supuestos

Publicado [1-3] · Tecentriq IV: 60 min inicial y 30 posteriores si tolerado; SC: aproximadamente 7 min. Bevacizumab: 90 min inicial, 60 segunda y 30 posteriores, condicionados a tolerancia previa. Tecentriq precede a bevacizumab el mismo día. El acceso venoso se conserva.

Sintético · Volumen, proporción SC y mezcla de primeras/segundas/posteriores.

Supuesto local · Recursos, esperas, preparación, observación y enfermería. La observación 30/15 min del ejemplo no es un intervalo obligatorio identificado en FT; 0 min adicionales no elimina la vigilancia.

Un circuito completo, cuatro medidas diferentes

Admisión y valoración → farmacia → espera → acceso IV → Tecentriq → observación local → transición/lavado → bevacizumab IV → observación final → desconexión y salida. Después, el recambio bloquea el sillón. Las fases son secuenciales por supuesto.

Administración: suma de los dos fármacos.

Ocupación: desde acceso hasta salida del sillón; el bloqueo del recurso añade recambio.

Estancia: fases previas + ocupación.

Enfermería: minutos de trabajo activo dentro de las fases; no se añaden otra vez a estancia.

Ejemplo reproducible: 200 visitas, de 0% a 60% SC

Una visita por paciente en el periodo; 10% primeras, 10% segundas y 80% posteriores. Se presupone selección clínica y tolerancia para tiempos abreviados. Todos los tiempos locales permanecen iguales entre escenarios.

Total del periodo	Referencia	Alternativa	Diferencia
Administración combinada	240,0 h	188,0 h	-52,0 h
Ocupación de sillón del paciente	395,0 h	343,0 h	-52,0 h
Estancia en hospital de día	561,7 h	509,7 h	-52,0 h
Enfermería activa	143,3 h	145,3 h	+2,0 h

Resultado aritmético del ejemplo: menos tiempo agregado de sillón y **más dedicación de enfermería** (43 min/visita IV; 44 SC). No demuestra ahorro operativo real. Cambia un supuesto cada vez para entender qué explica cada resultado.

Cómo interpretar la capacidad y los límites

Minutos disponibles = recursos × días × horas/día × 60 × disponibilidad (fracción). La carga de sillón divide ocupación + recambio por capacidad; enfermería usa minutos activos. Ejemplo: 4 sillones al 85%, 1 equivalente de enfermería al 80%, 20 días de 8 h; capacidades 544 y 128 h. Enfermería supera su capacidad en ambos escenarios. Estos cocientes no generan agenda ni colas. No se modelan costes, resultados clínicos, incidencias ni capacidad de farmacia. Elegibilidad, cribado de várices y vigilancia individual están sin verificar. El cambio IV a SC se trata como exposición posterior por simplificación local.

Fuentes primarias · consulta 11/09/2026

[1] [CIMA Tecentriq IV](#) · [2] [CIMA Tecentriq SC](#) · [3] [CIMA Avastin](#) (secciones 4.1, 4.2 y 4.4).

[EMA Tecentriq, PDF inglés](#); índices [Tecentriq](#) y [Avastin](#): actualización 21/07/2026 y 27/01/2026. Fichas en español consultadas en CIMA. Revisar las versiones vigentes antes del uso profesional. La indicación/dosis CHC se fundamenta en Tecentriq; Avastin es referencia de bevacizumab.